

居宅サービス計画書（第1表）

作成年月日	令和8年6月1日	計画作成者	介護支援専門員 山田 太郎
利用者氏名	中村 健二 様	事業所名	ケアプランセンター〇〇
生年月日	昭和25年（76歳）	性別	男
住所	〇〇市〇〇町3-9-1		
要介護状態区分	要介護2	区分支給限度額	19,705単位 〔新規〕

利用者及び家族の生活に対する意向
本人意向：「パーキンソン病と言われてから足がすくんで動きにくい。薬の効果が切れる時間帯（オフ期）に動けなくなるのが怖いが、リハビリをして少しでも動けるようになりたい」
家族意向（妻）：「日中は私が仕事（パート）で留守にするため、薬の飲み忘れや、家の中で動けなくなって倒れていないか心配。リハビリもさせてあげたい」

介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
なし

総合的な援助の方針
パーキンソン病による進行性の運動機能障害（すくみ足、日内変動）に対し、内服管理の徹底と、オン・オフの波に合わせた安全な運動機会の確保が必要。日中の妻の就労時間を安全に過ごせるよう、多職種で連携して在宅生活維持に努める。
【緊急時連絡先】 妻：中村〇〇（携帯 090-AAAA-AAAA）

生活援助中心型の算定理由	該当なし
--------------	------

同意欄
上記計画について説明を受け、内容に同意し交付を受けました。
令和8年6月1日 利用者署名：中村 健二

居宅サービス計画書（第2表）

【生活全般の解決すべき課題（ニーズ）と援助目標・内容】

生活全般の解決すべき課題 (ニーズ)・〔課題分析〕	長期目標 (期間)	短期目標 (期間) / ※評価指標	サービス内容・頻度・事業所
1. 妻不在時の服薬・転倒リスク 妻の不在時（火・木・土）に薬効が切れる時間があり、服薬忘れや転倒の危険がある。 〔課題分析〕妻のパート時間とオフ期が重なる点、および確認不在が危険因子。	服薬を正しい時間に確実にを行い、オフ期の転倒なく安全に日中を過ごす。 (R8.6.1～R8.11.30)	妻の不在日（火・木）の昼の服薬を忘れずに行い、オフ期の移動時は福祉用具を必ず使用して転倒がゼロになる。 (R8.6.1～R8.8.31) ※指標:内服ズレ回数、オフ期のヒヤリハット件数	【訪問介護（身体）】 昼食後の内服確認・声かけ・移乗見守り 事業所：ヘルパーセンターさくら 頻度：週2回（火・木）
2. 運動機能低下の進行 関節の硬さや歩きにくさが進行しており、リハビリで維持したい。	すくみ足への対処方法を学び、安全な歩行状態を維持する。 (R8.6.1～R8.11.30)	週1回専門的なリハビリを受け、すくみ足への跨ぎ動作等の指導を理解して実践できる。 (R8.6.1～R8.8.31) ※指標:関節可動域、歩行テストの実施	【訪問リハビリ】 理学療法士による歩行・すくみ足改善訓練 事業所：〇〇訪問看護ステーション 頻度：週1回（水）
インフォーマルサポート	妻がパートのない月・水・金・日に内服と移動の管理を行う。		

居宅サービス計画書（第3表）

【週間サービス計画表】

時間帯	月	火	水	木	金	土	日
12:30-13:00		訪問介護 内服確認		訪問介護 内服確認		妻パート不在 (家族フォロー)	家族と過ごす
14:00-14:40			訪問リハ 理学療法士				
その他							
モニタリング	毎月1回訪問。服薬状況とすくみ足の状態を確認する。						